

U08738298DFCD
H36924413273F

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS J30538283484 D

DÁRCIE VISAN SANTOS FERREIRA

IDADE: 48 PESO: 65 ALTURA: 159 PROFISSÃO: Jornalista
SINTOMAS: Dor de cabeça / Fadiga / Sonolência
QUEIXAS: Ronco / Perda de memória
MEDICAMENTOS: suplementos / RA
Faz reposição hormonal - gel.
MÉDICO: Dr. Alberto
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N
EXERCÍCIO FÍSICO: não está conseguindo (musculação)
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5(8) ALMOÇO: 5(12) LANCHE: 5(16) JANTAR: 5(20:30)
HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 6 - ou 8 hr
COCHILHO () SIM ☒ NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO Renca (esposo)
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
CIRURGIAS: () S () NASAL () S () AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não IMC: 31
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA
(N) ORTOPÉDICA () S () NEUROLÓGICA () OUTROS
30/08/24 - Avaliação.

06/09/24 P= 5,8 cmH₂O (média) Relata ainda sentir
IAH= 8,8 e/h incomodo cl/ apaulha
m de uso: 5h45' e sono não reparador
fuga: 9m
Natasha

20/09/24 P= 6,0 envio relatório 7/10
24 IAH= 8,0 e/h Dr. Denise
Fuga: 0,0 epm

04/10/24 P= 6 cmH₂O Relata que vai realizar
IAH= 4,4 e/h cirurgia nasal
m de uso: 5h18'
Natasha

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Darcie Visan Santos Ferreira

EXAME nº: 5644

SOLICITADO POR: Dr. Roberto Andrea Carlo Bonanomi

DATA: 20/06/2024

IDADE: 47 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h13min e concluído às 06h03min. A latência para o sono foi de 25 minutos e a latência para o estágio REM, de 70 minutos. O tempo total de sono foi de 407,5 minutos (06h47min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 87,6%. A distribuição do sono mostrou 10,2% de estágio 1, 41,5% de estágio 2, 25,2% de estágio 3 e 23,2% de sono REM. No período total de sono permaneceu 32,5 minutos em vigília, ocorreram 119 microdespertares (índice: 17,5/hora).

O índice de movimentos dos membros inferiores foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 35,5/hora, sendo 0,7 apneia/hora e 34,8 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 54/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 95% e a mínima de 83%.

(*) TTS⇒ Tempo Total de Sono

TTR⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (35,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (54/hora), algumas dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 64; máxima: 84 bpm.

O ronco foi esporádico e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 25 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava normal (70 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono manter-se no limite da normalidade (87,6%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 17,5/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (25,2%; normal: 10-12%) e REM (23,2%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (41,5%; normal: 45-55%). A porcentagem do estágio 1 (10,2%; normal: 8-10%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 11 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).